

Памятка пациенту: Вздутие живота

1. Что такое вздутие живота?

Вздутие (метеоризм, абдоминальное вздутие) — это субъективное ощущение переполненности, давления, «распирания» или увеличения объёма живота. Может сопровождаться объективным увеличением окружности живота (абдоминальная дилатация).

Основные проявления:

- Ощущение переполненности и тяжести
- Урчание в животе (борборигмы)
- Отрыжка и газообразование
- Дискомфорт или боль различной интенсивности
- Изменение формы живота
- Нарушения стула (запор, диарея, неустойчивый стул)
- Тошнота, снижение аппетита

2. Механизмы развития вздутия

- Избыточное газообразование в кишечнике
- Нарушение эвакуации газов из ЖКТ
- Повышенная чувствительность рецепторов кишечника
- Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта
- Дисбаланс кишечной микрофлоры

3. Причины вздутия живота

3.1 Алиментарные факторы (питание)

Газообразующие продукты:

- Бобовые (горох, фасоль, чечевица, нут)
- Крестоцветные (капуста, брокколи, цветная капуста)
- Лук, чеснок, артишоки
- Яблоки, груши, персики (высокое содержание фруктозы)
- Молочные продукты (при лактозной недостаточности)
- Цельнозерновые продукты
- Газированные напитки
- Искусственные подсластители (сорбитол, ксилит)

Неправильные пищевые привычки:

- Быстрый приём пищи и заглатывание воздуха
- Разговоры во время еды
- Переедание, нерегулярное питание
- Жевание жвачки, питье через соломинку

3.2 Функциональные расстройства

- Синдром раздражённого кишечника (СРК)
- Функциональная диспепсия, функциональное вздутие, функциональный запор
- Нарушение микробиоты кишечника

3.3 Органические заболевания

- Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит)
- Целиакия (непереносимость глютена)
- Хронический панкреатит
- Холецистит, желчнокаменная болезнь
- ГЭРБ, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки

3.4 Инфекционные причины

- Инфекция *Helicobacter pylori*
- Синдром избыточного бактериального роста (СИБР)
- Паразитарные и кишечные инфекции

3.5 Гормональные факторы

- Предменструальный синдром, менопауза, беременность
- Заболевания щитовидной железы (недостаточная функция)
- Сахарный диабет

3.6 Психосоматические факторы

- Хронический стресс, тревога, депрессия
- Соматоформные расстройства

3.7 Медикаментозные причины

- Антибиотики (дисбиоз)
- НПВП, опиоидные анальгетики, антидепрессанты, препараты железа

4. Алгоритм самонаблюдения и первичных мер

4.1 Ведение пищевого дневника

Записывайте ежедневно:

- Время приёма пищи, состав, количество, способ приготовления
- Когда появилось вздутие, его интенсивность (шкала 1–10)
- Сопутствующие симптомы, стресс, физическую активность
- Характер стула

4.2 Диетические рекомендации

Немедленные ограничения:

- Газировка, жвачка, напитки через соломинку
- Искусственные подсластители, жирное и острое, большие порции

Элиминационная диета:

1. Неделя 1 – исключить молочное
2. Неделя 2 – убрать глютен
3. Неделя 3 – исключить бобовые и капусту
4. Неделя 4 – ограничить фруктозу

Рекомендуемые продукты:

- Каши (рис, гречка, овсянка)
- Бананы, цитрусовые, морковь, кабачки, тыква
- Нежирное мясо, рыба, зелень (укроп, петрушка), имбирь, мята
- Кисломолочные (при переносимости)

4.3 Правила приёма пищи

- Ешьте медленно, тщательно пережёвывая
- Не разговаривайте за столом
- Маленькими порциями 4–5 раз в день
- Не ложитесь сразу после еды, избегайте очень горячего или холодного
- Пейте воду между приёмами пищи

4.4 Управление стрессом

- Регулярный сон (7–8 ч)
- Дыхательные практики, медитация, йога

- Умеренные физические нагрузки, отдых

4.5 Физическая активность

- Прогулки 30–40 мин ежедневно
- Упражнения для пресса, массаж живота по часовой стрелке
- Специальные позы йоги для пищеварения

5. Тревожные симптомы («красные флаги»)

5.1 Немедленно к врачу:

- Острая интенсивная боль
- Кровь в стуле, рвота с кровью
- Температура выше 38 °С
- Признаки кишечной непроходимости, желтуха

5.2 Плановый приём к врачу:

- Постоянное или усиленное вздутие
- Потеря веса > 5 % за 6 мес
- Изменение стула, ночные симптомы
- Семейная история болезни ЖКТ, возраст >50 лет
- Неясная анемия

6. Диагностический алгоритм

6.1 Первичная лаборатория:

- Общий анализ крови (лейкоцитарная формула), печёночные пробы, амилаза, липаза
- Кал на скрытую кровь, копрограмма, яйца глистов и простейшие

6.2 Специфические тесты:

- Антитела к *H. pylori* (IgG, IgA)
- Дыхательные тесты (лактолоза – СИБР, лактоза)
- Антитела при целиакии (глиадин, тТГ)
- Кальпротектин в кале

6.3 Инструментальные исследования:

- УЗИ органов брюшной полости

- ЭГДС, колоноскопия (по показаниям)
- Рентген, КТ/МРТ при необходимости

6.4 Дополнительно:

- Манометрия пищевода, рН-метрия, сцинтиграфия ЖКТ

Если посчитаете необходимым обратиться ко мне за медицинской консультацией – нужно ответить на эти вопросы

Первичная диагностика метеоризма

1. Характеристика вздутия

1. Сколько времени проходит от приёма пищи до появления вздутия (сразу, через час и т.д.)?
2. В какое время суток обычно возникает вздутие (утро, день, вечер)?
3. Как часто возникает вздутие (ежедневно, несколько раз в неделю, эпизодически)?
4. Как долго длится вздутие?
5. Есть ли боль в животе? Если да, где именно и какая она — острая, тупая, колющая?
6. Есть ли урчание, ощущение переливания, тошнота или отрыжка?
7. Меняется ли вздутие в зависимости от положения тела (сидя, стоя, лёжа)?
8. Усиливается или уменьшается вздутие при физической активности?

2. Пищевые и поведенческие факторы

9. Есть ли продукты, которые однозначно не вызывают вздутие?
10. Отмечаете ли вы непереносимость лактозы (молочных продуктов), глютена, бобовых или капусты?
11. Как часто употребляете острое, жирное, жареное, фастфуд?
12. Едите ли быстро, разговариваете ли во время еды, глотаете ли много воздуха (аэрофагия)?
13. Кушаете ли молча, сфокусировано на еде?
14. Пробовали ли вести пищевой дневник и отслеживать реакцию организма на разные блюда?

3. Функции ЖКТ

- 15. Есть ли запоры, поносы, слизь или кровь в стуле?
- 16. Были ли резкие изменения в весе?
- 17. Принимали ли вы недавно антибиотики?

4. Психоэмоциональное и общее состояние

- 18. Есть ли стресс, тревожность, эмоциональные перегрузки?
- 19. Какой у вас режим сна и физической активности?

5. Медицинский анамнез

- 20. Были ли обследования на *H. pylori*, гастрит, СРК (синдром раздражённого кишечника)?
- 21. Проходили ли вы обследование у гастроэнтеролога (ФГДС, колоноскопия)?
- 22. Есть ли тревожные симптомы — ночные пробуждения из-за боли, анемия, сильная усталость, семейная история рака ЖКТ?

6. Гинекология (для женщин)

- 23. Есть ли связь вздутия с фазами менструального цикла?
- 24. Есть ли гинекологические заболевания (например, эндометриоз)?